

TIROIDITIS

Elena González Arnáiz, Mirian Alejo Ramos, Diana Ariadel Cobo.

INTRODUCCIÓN

Grupo de enfermedades inflamatorias que afectan la glándula tiroidea de diferente etiología (autoinmune, bacteriana o virales, fibrosis, fármacos, etc). Pueden cursar con dolor y sintomatología inflamatoria local asociado a síntomas de disfunción tiroidea. Se clasifican en:

- **Dolorosas:** subaguda de Quervain, aguda infecciosa, por traumatismos, por radiación.
- **No dolorosas:** silente, postparto, crónica de Hashimoto, fibrosante de Riedel, inducida por drogas.

Este capítulo está centrado en las que pueden originar dolor cervical anterior o clínica compresiva local como síntomas principales.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Tiroiditis subaguda, granulomatosa o de De Quervain

Inflamación aguda granulomatosa de la tiroides que ocasiona un bocio blando y doloroso, es la causa más frecuente de dolor en la región tiroidea. La etiología es probablemente vírica, debido a que frecuentemente va precedida de infección de vías respiratorias.

Diagnóstico

- **Clínica:** dolor cervical anterior con frecuencia irradiado a mandíbula y oídos. Pude cursar con febrícula o fiebre elevada y su curso clínico suele ser autolimitado. El 50% de los pacientes cursa con hipertiroidismo, evolucionando a hipotiroidismo en el 25% de los casos.
- **Exploración física:** la palpación tiroidea muestra una glándula dolorosa, agrandada y de consistencia dura.
- **Analítica urgente:** Hemograma y bioquímica. Elevación de VSG y PCR, leucocitosis, anemia leve.
- **Ecografía:** heterogénea, hipoecogénica e hipovascular (no es imprescindible para el diagnóstico).

Diagnóstico Diferido

- **Analítica no urgente:** Los valores de hormonas tiroideas: TSH, Tiroxina (T4) libre, Triiodotironina(T3), antiTPO y anti TG fluctúan, dependiendo de la fase cronológica en que se encuentre el paciente. La positividad de anticuerpos antitiroideos (Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPO, por sus siglas en inglés), Anticuerpos antitiroglobulina (Tg), Anticuerpo antirreceptor de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés) es transitoria.
- La captación de I^{131} en la gammagrafía es baja o anulada, puede ser normal si solo existe afectación local.
- Anatomía patológica (no suele precisarse): células gigantes multinucleadas.

Tratamiento

El tratamiento suele ser sintomático, principalmente se utilizan antiinflamatorios no esteroideos y a veces corticoides y/o β bloqueantes:

- Ácido Acetilsalicílico: 500mg/6-8h o Ibuprofeno 600mg/8h.
- Si no responden se puede asociar Prednisona 15-40mg/día en pauta descendente hasta 4-6

semanas.

- Si tirotoxicosis: β bloqueantes; Propranolol 20-40 mg/8h o Atenolol 25-50 mg/12- 24h.
- Si hipotiroidismo: Levotiroxina 50-100 mcg/día durante 6-8 semanas.

La función tiroidea se normaliza en el 90% de los casos y sólo el 10% evolucionan a un hipotiroidismo permanente.

Tiroiditis piógena, aguda o supurativa

Inflamación tiroidea aguda de origen bacteriano. Se produce por diseminación hematógena o por contigüidad, debido a fístulas desde el seno piriforme. Presenta una baja incidencia (2 pacientes/año en un hospital terciario).

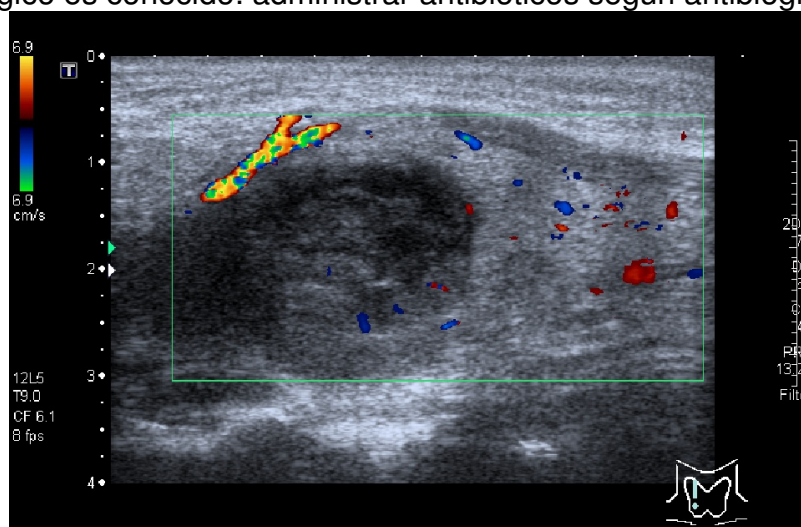
Diagnóstico

- Clínica: bocio nodular doloroso, signos de inflamación local, deglución dolorosa, fiebre y mal estado general.
- Analítica: hemograma, coagulación y bioquímica. VSG elevada y leucocitosis con desviación izquierda.
- Hemocultivos: previos al tratamiento antibiótico empírico.
- Ecografía: se debe realizar si se sospecha esta patología para objetivar el absceso tiroideo en fases iniciales.
- Punción aspiración con aguja fina (PAAF): realizar si masa cervical dolorosa, nos permite confirmar el diagnóstico y recoger muestra para cultivo.

Tratamiento

Antibioterapia sistémica de amplio espectro hasta resultados del cultivo, algunos casos precisan drenaje quirúrgico.

- El tratamiento empírico en inmunocompetentes sin alergia a penicilinas: penicilina resistente a penicilinasas con inhibidor de β -lactamasas (piperacilina con tazobactam).
- Si sospecha de infección por SARM, añadir Vancomicina 1 g/12 h o 500 mg/6 h.
- Si el agente etiológico es conocido: administrar antibióticos según antibiograma.



Mujer de 41 años con fiebre y dolor cervical anterior, en la ecografía se observa absceso en lóbulo tiroideo derecho.

Tiroiditis inducida por traumatismo

Puede estar causada por traumatismo directo de la zona cervical anterior, palpación tiroidea vigorosa o por manipulación durante la cirugía. El paciente presenta dolor cervical moderado y tirotoxicosis transitoria.

Tiroiditis por radiación

Dolor tiroideo moderado entre 5 y 10 días después de la administración del I ¹³¹, se produce una inflamación de la glándula debido a la necrosis de las células foliculares inducida por la radiación. Se resuelve de forma espontánea en pocos días.

Tiroiditis de Riedel

Tiroiditis no dolorosa poco frecuente. Es una manifestación local de un proceso inflamatorio fibrosante sistémico de base autoinmune.

Diagnóstico

- Clínica y exploración física: masa tiroidea pétreo y adherida que cursa con síntomas de compresión local como disfonía o disfagia.
- En analítica urgente se solicitará: **hemograma** con formula y recuento leucocitario, **bioquímica**, PCR, VSG y calcio, **coagulación** básica. En analítica diferida PTH para descartar coexistencia de hipoparatiroidismo.
- TAC o RM: Para evaluar la extensión de la fibrosis y el grado de infiltración del tiroides y órganos adyacentes.
- Biopsia: Diagnóstico de confirmación.

Tratamiento

Suele ser quirúrgico si compresión traqueal o esofágica, o farmacológico con corticoides, tamoxifeno, rituximab o micofenolato.

	Silente	Postparto	Subaguda	Aguda	Crónica
Dolor	-	-	++	++	-
Autoinmunidad	++	++	++	-	++
TSH y T4	Normal, hipo o hipertiroidismo	Normal, hipo o hipertiroidismo	Normal, hipo o hipertiroidismo	Normal	Normal o hipotiroidismo
Anticuerpos (antiTPO, anti TG)	+	++	+/-	-	++++
TG	Elevada	Elevada	Elevada	Normal	Normal
VSG	Normal	Normal	Elevada	Elevada	Normal
Ecografía/Doppler	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular
Gammagrafía	Captación disminuida	Captación disminuida	Captación disminuida	Normal	Normal
Progresión hipotiroidismo	+/-	++/-	+/-	-	+++

Diagnóstico diferencial de las tiroiditis.

A RECORDAR

- **SOSPECHA** si dolor cervical anterior, disfagia, disfonía. A veces síndrome general asociado.
- **PRUEBAS** analítica (Importante pedir VSG y PCR) y ecografía.
- **TRATAMIENTO** analgésico, hipertiroidismo o hipotiroidismo, antibiótico si es aguda.

- **VALORAR** seguimiento en consulta externa endocrinología. Algunas por probabilidad de desarrollo de hipotiroidismo permanente.

BIBLIOGRAFÍA

- Oleaga Alday A, Goñi Goicoechea F, Lizarraga Zufiaurre A. Tiroiditis. Manual del residente de Endocrinología y Nutrición.2018.
- Burman KD. Overview of thyroiditis. UpToDate. 2011.
- Elizabeth N. Pearce, M.D., Alan P. Farwell, M.D., and Lewis E. Braverman, M.D. Thyroiditis. N Engl J Med 2003;348:2646-55.